

05. 循环系统更新

时长：03:59

教学单

课程总结

本视频对传统循环系统模型进行了深入更新，展示了实际上存在三个独立的静脉系统。您将了解血液与心脏之间复杂的相互作用，以及血液可以采取的不同路径，从而阐释循环的内在智慧。Herveillat先生和Batson先生等先驱的理论有助于重新思考静脉的作用，并详细了解基底静脉系统、卵黄静脉系统和脐静脉系统。还将探讨对腰痛和局部酸中毒等常见病症的实际影响，为您提供具体的工具来丰富您的整骨疗法实践。

循环系统：更新

血管通路的形成

循环系统的传统图景是：血液从心脏经**动脉**流出，再经**静脉**返回心脏。虽然这是事实，但实际上存在三种不同的静脉系统：

- **椎体系统：** 专门与椎体系统相关。
- **门静脉系统：** 引流所有**外胚层**、**中胚层**和**内胚层**系统。
- **第三种静脉系统。**

血液确实会返回心脏，但它也可以根据心脏的压力和减压情况，掉头或选择其他通路。例如，如果门静脉系统负荷过重无法回流，血液就会选择另一条通路。它将通过膈膜交换区域使用**腔静脉回流系统**。

这意味着压力可以进行调整。血液并非遵循简单的闭合回路，而是可以走各种通路。这个系统具有**内在的智慧**，始终旨在返回心脏。

静脉系统的新视角

血液确实从心脏流出并返回。然而，我们对静脉系统乃至整个循环系统的看法，可以追溯到17世纪。现在，这种观念已经**更新**。

这一新理解的前驱是**M. Herveillat**和**M. Batson**。一个问题出现了：“但我一直被告知静脉含有瓣膜以防止血液回流。”实际上，这些瓣膜只存在于**大静脉**中，而非整个网络。这种小瓣膜非常少。

待研究的不同静脉系统

我们将研究：

- **主静脉**： 它们将演变为亚主静脉和上主静脉。
- **卵黄系统**： 与肝脏相关。
- **脐带系统**： 它将被重新映射到椎体-腔静脉-门静脉系统，并重新整合到整骨疗法实践中。

主静脉系统将发生巨大的变化，我们将详细了解它是如何形成组织和结构，并整合到**外胚层**和**中胚层**结构中的。

已经开发出一种将此付诸实践的方法。理解其意义至关重要。

实际和临床意义

淤滞和**腹压**变化可能产生重要后果。例如，**腰痛**可能是门静脉系统超负荷的结果。

因此，有必要通过这种门静脉超负荷来“卸载”椎体系统。这就是**椎间盘病变**的整个机制所在。

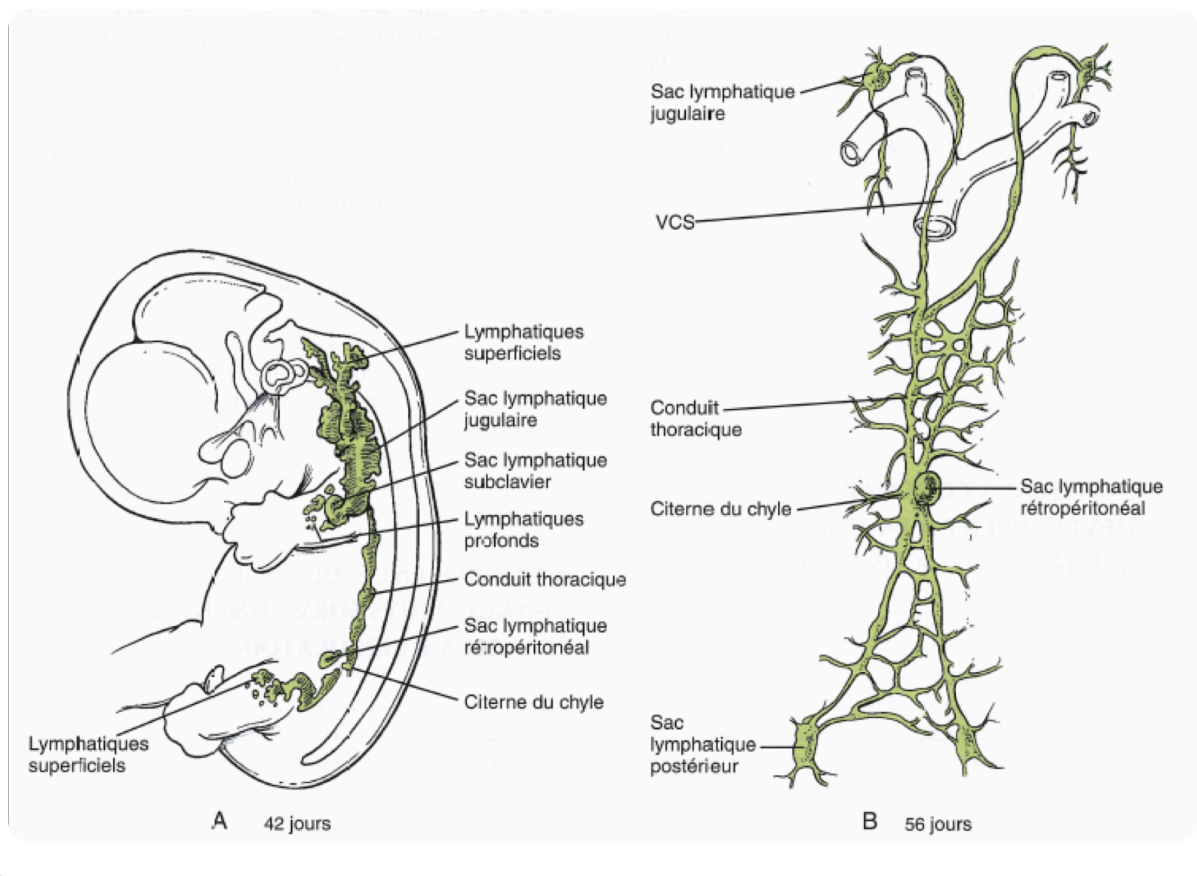
任何形式的淤滞都会导致**酸性**，即使是局部酸性，也需要解决。始终使用相同的模式。例如，**骶骨肿瘤**几乎总是伴有左肾、左肺和大脑的**转移**。在轨迹中观察到一种常数。

在**前列腺**问题中，也可以发现相同的模式。此外，椎体窦和小骨盆的骶窦之间存在**血管连续性**。

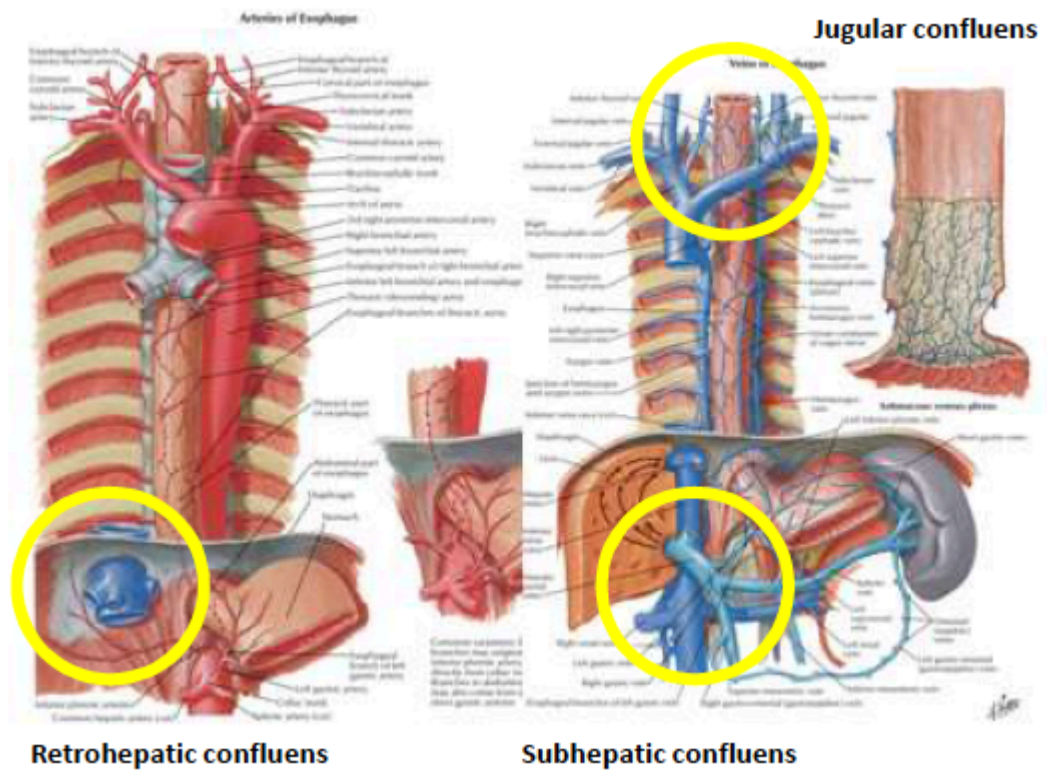
从手臂抽取的血液并不能反映可能从静脉系统、动脉系统或其他系统中抽取的全部血液。



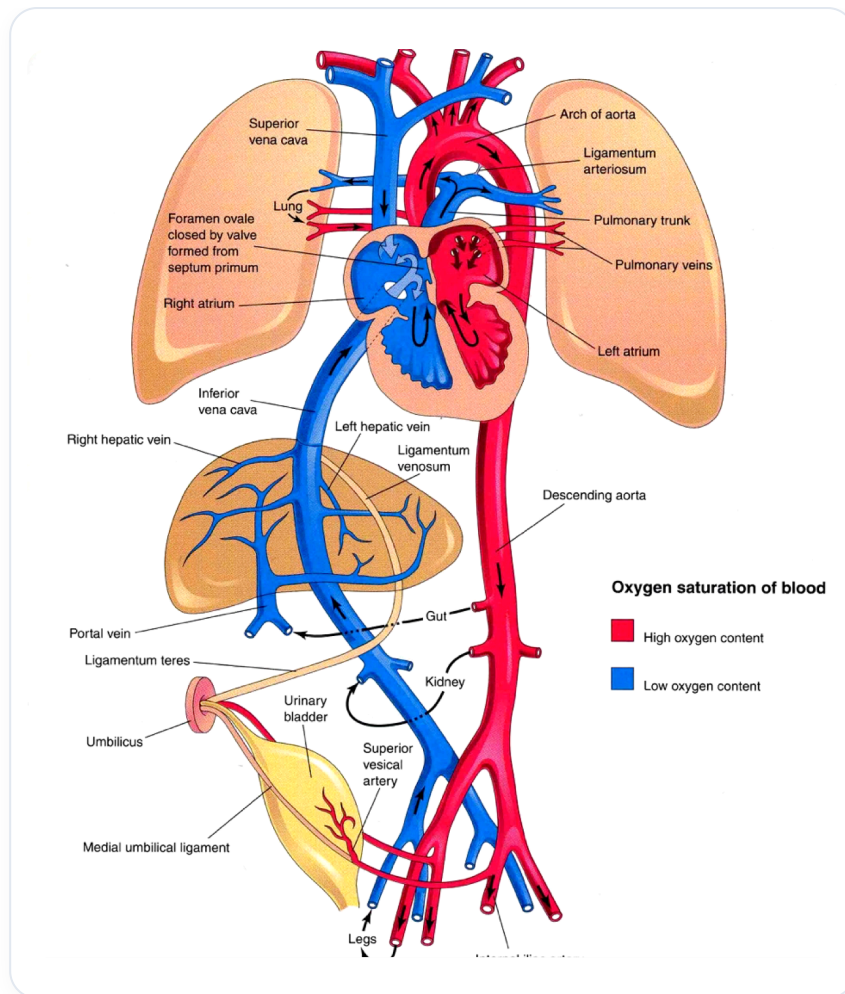
图一 心血管系统



图一 淋巴系统发育



图一 食管侧支静脉



图一 人类胎儿循环